

Questions de Résidanat 2025

Sujet : 19

Déshydratations aiguës de l'enfant

Questions à Réponses Multiples

Objectif N° 1 : Définir la déshydratation aiguë de l'enfant

1. La déshydratation aiguë de l'enfant :

- A. Est secondaire à un déficit chronique en électrolytes
- B. Résulte d'un bilan positif entre les entrées et les sorties en eau
- C. Touche surtout le nourrisson
- D. Complique le plus souvent les gastroentérites aiguës
- E. Représente une cause majeure de morbidité
- F.

Objectif N° 4 : Etablir le diagnostic positif d'une déshydratation en se basant sur les données de l'anamnèse et de l'examen physique.

2. Concernant la déshydratation du nourrisson :

- A. Le diagnostic positif repose sur des éléments cliniques et biologiques
- B. Elle est sous-estimée chez un enfant hypotrophe
- C. La perte de poids récente est un signe objectif du diagnostic
- D. Elle peut se compliquer de troubles hydroélectrolytiques
- E. Les manifestations neurologiques peuvent être un signe de gravité

3. Les signes de déshydratation extracellulaire sont :

- A. Une fièvre aiguë
- B. Une hypotonie des globes oculaires
- C. Une dépression de la fontanelle antérieure
- D. Une oligurie
- E. Une tachycardie, un TRC allongé avec une hypotension artérielle

4. Les signes de déshydratation intracellulaire sont :

- A. Une soif intense

- B. Une sècheresse des muqueuses
- C. Un temps de recoloration (TRC) allongé
- D. Un état de coma
- E. Des yeux enfoncés

Objectif N° 5 : Evaluer le degré de sévérité d'une déshydratation aigue de l'enfant selon le score de l'OMS

5. Dans le score de déshydratation :

- A. Une SatO₂ inférieure à 94% est coté à 2
- B. Un nourrisson plaintif est coté à 2
- C. Un état de choc hypovolémique majore le score de 5
- D. Une langue sèche est cotée à 3
- E. Une fontanelle très déprimée est cotée à 2

6. La déshydratation aigue chez l'enfant :

- A. Est légère si la perte pondérale est entre 5 et 10%
- B. Correspond au stade 3 de déshydratation si le score ≥ 9
- C. Est définit comme sévère en cas de choc septique associé
- D. Est sévère si le déficit hydrique = 100 ml/kg/j
- E. Est modérée si le score de déshydratation est à 8

7. Une déshydratation d'un nourrisson est dite modérée si :

- A. La perte pondérale = 5%
- B. Le score de déshydratation est égal à 4
- C. Le nourrisson est âgé de moins de 3 mois
- D. Le déficit hydrique est à 30 ml/kg/j
- E. Le nourrisson est fébrile

8. Les items du score d'OMS de déshydratation sont :

- A. Le poids
- B. La fréquence respiration
- C. L'état neurologique
- D. Le pli cutané
- E. La Saturation en oxygène

Objectif N° 6 : Etablir la prise en charge d'une déshydratation aigue en fonction de sa sévérité

9. La réhydratation orale :

- A. Impose l'arrêt de l'allaitement maternel
- B. Se base sur le SRO
- C. Est instaurée à l'hôpital en cas d'hypotrophie
- D. Est indiquée si le score OMS est à 9
- E. A pour objectif de compenser la totalité des pertes sur 48h

10. Lors d'une déshydratation stade 2 chez un nourrisson âgé de 1 mois :

- A. Une hospitalisation est indiquée
- B. La totalité des pertes est compensée durant les 2 premières heures
- C. La compensation des pertes en cours se fait par 50ml/Kg de SRO
- D. L'allaitement artificiel est arrêté durant les 6 premières heures
- E. Une réhydratation parentérale est indiquée d'emblée

11. La réhydratation parentérale :

- A. Est indiquée d'emblée en cas de déshydratation modérée
- B. Est indiquée si échec de la voie orale
- C. Se base sur une perfusion intraveineuse de SRO
- D. Commence par un remplissage vasculaire si état de choc
- E. Correspond aux besoins de maintenance + déficit hydrique + les pertes par 24 heures

12. La réhydratation parentérale doit être privilégiée dans les situations suivantes :

- A. Un score de déshydratation à 4
- B. Une déshydratation sévère
- C. Des troubles de la conscience
- D. Une suspicion d'une urgence chirurgicale
- E. Une température à 39°

13. Au cours d'une déshydratation chez nourrisson de 10kg de poids avec au bilan la $\text{Na}^+ = 120 \text{ mmol/L}$:

- A. La déshydratation extracellulaire est importante
- B. Si l'hyponatrémie est asymptomatique, la vitesse de correction est de 0,5 mmol/l/h
- C. Une correction trop lente expose au risque de myélinolyse centropontine
- D. La quantité de sodium à apporter est de 3 mEq de NaCl
- E. Si le nourrisson est en coma, la vitesse de correction de la natrémie est de 5 mmol/l/h initialement

14. Au cours d'une déshydratation avec une natrémie à 151 mmol/L :

- A. Une correction trop lente expose au risque d'œdème cérébral
- B. La baisse de la natrémie doit être de 5 mmol/l/h
- C. La réhydratation est effectuée sur 48 heures.
- D. Le rythme de perfusion est rapide (sur 4 heures) puis lent (20 heures)
- E. La quantité de sodium par 500 ml perfusion de sérum G 5% est de 2 ampoules et $\frac{1}{4}$

15. Le soluté de réhydratation par voie orale (SRO) : Oralyte est :

- A. Indiqué après chaque selle liquide pour compenser les pertes en cours
- B. Caractérisé par une osmolarité supérieure à celle du plasma
- C. Administré en cas de déshydratation stade I et II
- D. Composé de glucose, sodium, potassium et calcium
- E. Est moins concentré que les nouveaux SRO en glucose et sodium

Cas cliniques

Cas clinique N°1 :

Ahmed , âgé de 2 mois , est amené aux urgences pour des diarrhées aiguës (6 épisodes par jour) évoluant depuis 48 heures.

Il y a 1 semaine, son poids était à 5 kg.

A l'examen, son poids est à 4kg500.

Sa température est à 38 ,5°, il a un pli persistant, sa respiration est ample avec une FR : 60 cycles/min, son état neurologique est normal, la fontanelle antérieure (FANT) est légèrement déprimée, sa langue est un peu desséchée, le TRC<3, TA : 90/40 mmhg, les globes oculaires sont légèrement enfoncés.

1. Les signes de déshydratation extracellulaire chez Ahmed :

- A. Fièvre
- B. Pli persistant
- C. Langue un peu desséchée
- D. TRC<3
- E. FANT légèrement déprimée

2. Le score de déshydratation d'A Ahmed est estimé à :

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9
- E. 10

3. Il s'agit d'une déshydratation :

- A. Stade II avec un score à 7
- B. Stade II avec une perte pondérale de 10 %
- C. Stade II avec un score à 8
- D. Stade II avec une perte de 9%
- E. Stade III avec un score à 9

4. La prise en charge consiste à :

- A. Hospitaliser en urgence
- B. Indiquer une réhydratation parentérale
- C. Conseiller l'allaitement maternel avec la réhydratation
- D. Mettre une sonde nasogastrique d'emblée pour la réhydratation
- E. Indiquer la réhydratation orale par SRO aux urgences

Cas clinique N°2 :

Zeineb , nourrisson âgée de 13 mois, présente depuis 24 heures, 10 selles liquidiennes abondantes .

A l'examen : nourrisson apathique, poids : 8,8 kg (son poids il y a une semaine 10 kg), T° : 38,5° , elle a un pli cutané persistant, sa langue est un peu desséchée, sa fontanelle est très déprimée , ses globes oculaires sont très enfoncés, sa FC à 180 battements /min , le TRC à 4 sec, TA à 60/ 30, sa respiration est ample, FR à 60 cycles/min.

1. Le score de déshydratation de Zeineb :

- A. 11
- B. 12
- C. 13
- D. 15
- E. 17

2. Il s'agit d'une déshydratation :

- A. Stade III avec un score à 13
- B. Stade III avec une perte pondérale de 12%
- C. Stade III avec un score à 17
- D. Stade III avec une perte de 10%
- E. Stade III avec un état de choc

Le bilan demandé : Na⁺= 121 mmol/l, k⁺ = 4.8 mmol/l , Urée 20= mmol/l
créatinine =110umol/l , Glycémie =1,2g/L

GDS: 7,2, HCO₃: 12, BE: -12 PCO₂ : 30 glycémie : 5,6 mmol/l

3. Ce nourrisson présente :

- A. Une acidose métabolique non compensée
- B. Une hyperglycémie
- C. Une hyponatrémie
- D. Une hyperkaliémie
- E. Une insuffisance rénale

4. Devant cet état de déshydratation :

- A. L'hospitalisation est systématique
- B. L'apport hydrique est de 150 ml/kg sur 24 heures
- C. La perfusion initiale ne doit pas contenir du potassium
- D. La vitesse de correction du déficit sodé est de 15 mmol/L/h
- E. Un remplissage de 100 ml/kg de sérum Glucosé 5% doit être administré en urgence

Cas clinique N°3 :

Nourrisson Seif, âgé de 8 mois, présente 5 selles liquidiennes abondantes, depuis 24 heures.

A l'examen : nourrisson réactif, son poids: 7,7 kg, T°, 37°, il a un pli cutané pâteux, langue un peu desséchée, fontanelle légèrement déprimée, globes oculaires normaux, FC à 120 battements /min, TRC 2 sec, extrémités chaudes, TA normale à 70/50. Sa respiration est calme et sa FR est à 37 cycles/min.

1. Devant cet état de déshydratation :

- A. Le score de déshydratation est estimé à 4
- B. Le déficit hydrique est entre 50 et 100 ml/kg/j
- C. La perte pondérale est inférieure à 5%
- D. La réhydratation se fait par des solutés de réhydratation orales
- E. Le lait artificiel doit être arrêté durant 48 heures.

Après 48 heures d'évolution à domicile, les diarrhées sont de plus en plus fréquentes et se sont associées à des vomissements, le score de déshydratation est estimé à 10, au bilan : Na⁺= 159mmol/L, k⁺ = 6,5 mmol/L, Urée= 25 mmol/l, créatinine= 160 umol/L, GDS: PH :7,1, HCO₃: 10, BE: -12 PaCO₂ =22

2. Concernant la stratégie de prise en charge pour cet enfant

- A. Une correction de l'acidose est indiquée
- B. Les pertes doivent être compensées sur 6 heures
- C. La perfusion de réhydratation doit contenir 38,25meq/L de NaCl
- D. La vitesse de réhydratation doit être lente sur 48heures
- E. La phase rapide de réhydratation doit durer 2 heures

Après 6 heures de prise en charge, le nourrisson a présenté une crise convulsive brève d'une minute, un bilan a été pratiqué : $\text{Na}^+ = 140\text{mmol/l}$, $\text{K}^+ = 2,8\text{ mmol/l}$, glycémie = $6,2\text{ mmol/l}$, urée= 18mmol/l , créatinine= $150\mu\text{mol/l}$, $\text{PH} = 7,29$ $\text{HCO}_3^- = 18$ $\text{PaCO}_2 = 30$

3. **Les causes probables de cette convulsion sont :**

- A. Un œdème cérébral
- B. Une hyperglycémie
- C. Une hypokaliémie
- D. Une insuffisance rénale
- E. Une acidose métabolique